

- **Memoria.** El déficit observado en la EA es muy extenso en la medida en que afecta tanto a la capacidad de evocar como recuperar información, verbal o visual, plenamente consolidada (Morris y Balota, 2001). Precozmente se afectan las memorias episódica y semántica (Becker, López y Butters, 1996), con una severa alteración en la capacidad para recordar hechos recientes y remotos. La rapidez del olvido parece relacionarse con la alteración de la transferencia de información, o la consolidación, en un almacenamiento a largo plazo, con mayor impacto en los dos primeros minutos de la retención (Kopelman y Corn, 1988). Así, la afectación de la memoria abarca el déficit de fijación o memoria anterógrada, el de recuerdo o memoria retrógrada, así como la consolidación del material expuesto. Ello da lugar a falsos reconocimientos y confabulaciones (Constantinidis y Richard, 1985). Muestran una desorientación temporal y espacial con un empeoramiento a medida que la demencia progresa. De lo descrito, se puede concluir que es una auténtica amnesia, en la medida en que el paciente ni aprende ni recuerda, por falta de almacenamiento o consolidación de la nueva información (Alberca, 2002). No obstante, algunas funciones mnésicas como la memoria procedural (Brandt y Rich, 1995; Deus, 1995) o la memoria incidental pueden preservarse hasta estadios tardíos (Deus, 1995). El patrón de déficit mnésico observado parece relacionarse con la afectación de distintos sustratos cerebrales, la afectación bitemporal y del cerebro basal anterior (Brandt y Rich, 1995; Desgranges, Baron, De la Sayette y colaboradores, 1998).
- **Lenguaje.** Alois Alzheimer, en su descripción de 1907, ya puso especial atención en la presencia de que la alteración del lenguaje coexistía con los déficits mnésicos característicos (Deus, 2001). Esta alteración es precoz y frecuente, aunque muy heterogénea, siendo la anomia o incapacidad en encontrar nombres el signo neuropsicológico más evidente. La anomia, que afecta tanto a los nombres propios como a los comunes, puede ser la forma de presentación clínica más importante hasta el 10 % de los pacientes (Price, Gurvit, Weintraub y colaboradores, 1993) y se acaba encontrando en todos los casos avanzados. El déficit lingüístico puede etiquetarse de tipo afásico y sigue un patrón de deterioro cognitivo que se relaciona con una pérdida gradual de los circuitos neuronales implicados en la función lingüística. Inicialmente se manifiesta como una afasia nominal, luego con características de afasia sensorial transcortical y en las fases finales se puede caracterizar como una afasia global (Deus, 2001). En primer lugar, suele afectar el componente semántico (Monsch, Seifritz y Taylor, 1997) lo que sugiere una afectación de la corteza temporal inferior de predominio izquierdo (Cappa, Binetti, Pezzini y colaboradores, 1998). Posteriormente, se altera lo sintáctico y morfológico siendo tardía la alteración del aspecto fonológico que afecta a la capacidad de producción verbal (Alberca, 2002). Ello sugiere una mayor afectación perisilviana izquierda de predominio posterior, inicialmente, y que luego se extiende anteriormente. La alexia y la agrafia son relativamente tardías (Alberca, 2002) y son sutiles al inicio de la enfermedad manifestándose, inicialmente, una alteración de la escritura (Deus, 2001) que puede estar, en ocasiones, más afectada que la capacidad de producción oral (Junqué, 1994).
- **Cálculo.** La alteración del lenguaje numérico es frecuente y precoz ocasionando dificultades en la vida diaria. Los números pierden su valor simbólico y el paciente es incapaz de hacer uso del dinero. Dicha afectación cognitiva se relaciona con una disfunción del lóbulo parietal inferior y giro temporal inferior izquierdo (Junque y Jurado, 1994; Alberca, 2002).

- **Praxis.** La apraxia, definida como la vertiente patológica de la capacidad gestual, ya aparece en la demencia leve y se correlaciona con la afasia (Travniczek-Marterer, Danielczyk, Simanyi y colaboradores, 1993) empeorando a lo largo del curso de la enfermedad. Este déficit cognitivo puede manifestarse de diferentes formas. Los primeros déficits se manifiestan como la dificultad en la reproducción de un modelo sencillo (apraxia constructiva), en el espacio bidimensional o tridimensional, y que suelen acompañarse de la capacidad de ponerse la ropa, quitársela o recordar el orden de colocación de las prendas de vestir (apraxia del vestirse). Posteriormente aparecen dificultades en la reproducción de movimientos manuales (apraxia ideomotriz por imitación) seguida por la alteración en la ejecución de movimientos manuales simbólicos a la orden (apraxia ideomotriz simbólica) y en la capacidad para manipular objetos (apraxia ideatoria) (Constantinidis y Richard, 1985). La precocidad, frecuencia e intensidad de la apraxia ideomotora es mayor que la de la apraxia ideatoria, si bien ambas están presentes en el 35 % de pacientes con EA leve, en el 58 % de los pacientes con EA moderada y en el 98 % de los casos con demencia severa (Edwards, Deuel, Baum y colaboradores, 1991).
- **Gnosis.** Las alteraciones de las capacidades visuales y visoespaciales se manifiestan en el reconocimiento de los objetos e integración de las percepciones, así como en la capacidad para entender y manipular las relaciones de los objetos en el espacio. Estos déficits pueden aparecer de forma precoz en el curso de la enfermedad. Inicialmente el paciente puede perderse en espacios poco frecuentes y su desorientación espacial irá progresando paulatinamente hasta perderse en su propia casa. Durante el curso evolutivo de la enfermedad el paciente ni reconocerá las caras, inicialmente de personas poco habituales y progresivamente de los propios familiares, ni los objetos, ni los colores, ni las relaciones espaciales entre los objetos. Este conjunto de alteraciones gnósicas visuales se relacionan con las lesiones en la corteza visual asociativa ubicada en los lóbulos occipitales y en zonas colindantes de los lóbulos parietales. Sin embargo, las agnosias no afectan solamente a la esfera visual. El paciente, en estadios avanzados, puede no reconocer su propio esquema corporal con una dificultad en la expresión consciente, mediante el lenguaje o los gestos, del dolor. Finalmente, por afectación fronto-parietal, el paciente también puede mostrar una ignorancia o falta de conciencia del déficit (anosognosia) lo que le lleva a minimizar sus alteraciones cognitivas y sus quejas se reducen solamente a pequeños problemas mnésicos (Junqué y Jurado, 1994; Junqué, 1994; Alberca, 2002).
- **Funciones ejecutivas.** Las capacidades ejecutivas son las encargadas del razonamiento, la planificación y la flexibilidad para regular y verificar los patrones de conducta que permiten al sujeto adaptarse al medio y cumplir las normas sociales. El déficit de las capacidades ejecutivas se manifiesta con los trastornos de la memoria de trabajo, la búsqueda de semejanzas o diferencias entre dos elementos, la planificación y organización de tareas o proyectos de futuro, en la capacidad de juicio social, la conciencia de enfermedad y en la presencia de cambios de conducta o de personalidad. Este patrón de alteraciones se relaciona con las lesiones del lóbulo frontal o de los circuitos fronto-corticales y fronto-subcorticales.